

1 - Concerne : médecins GO, MAR, sages-femmes

2 - Diagnostic :

- TA > 140/90 mm d'Hg ET
- Protéinurie augmentée :
 - o Rapport Protéinurie/Créatinurie > 0.03 g/mmol ou > 30 mg/mmol ou > 300 mg/g
 - o Protéinurie des 24h > 0.3 g/24h

Survenant après 20 SA et jusqu'à 6 semaines en post partum :

Conversion Rapport P/C : $P/C \text{ (g/mmol)} \times 8.84 = \text{Protéinurie des 24h}$.

Evaluation de la protéinurie sur bandelette urinaire

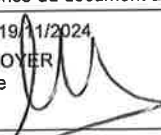
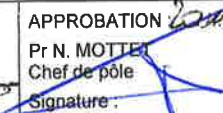
Négatif	< 0,1 g/l
Traces	0,15 g/l
+	0,3 g/l
++	1 g/l
+++	3 g/l

3 - Prise en charge initiale prééclampsie :

- **Réalisation d'un bilan sanguin** permettant d'évaluer la sévérité : NFS, TP, TCA, Bilan hépatique, Bilan rénal, Schizocytes, Haptoglobine, Acide urique, fibrinogène, LDH, Rapport P/C.
- **Examen clinique** : Réflexes ostéo tendineux, évaluation des signes fonctionnels d'HTA, cycle tensionnel, diurèse.
- **Echographie** : Biométries, Doppler artères utérines, Doppler ombilical et Doppler cérébral.
- **Hospitalisation** avec réalisation d'une protéinurie des 24h de référence.

4 - Evaluation de la sévérité :

Critères cliniques	Critères biologiques
- TA > 160/110 mm d'Hg - Oligurie 500cc/24h - Dyspnée - Douleur thoracique - OAP - Barre épigastrique - Céphalées intenses - Troubles visuels - ROT vifs, polycytiques et diffus	- Créatinémie > 90 µmol/L - Plaquettes < 100 G/L - ASAT ou ALAT > 2N - Protéinurie > 3h/24h soit 300mg/mmol

Intitulé et référence du document associé : aucun			
REDACTION : 19/11/2024 Dr L. LUCOT ROYER Chef de clinique Signature : 	VERIFICATION : 20/11/2024 Mohcine AICH Qualiticien – Direction Qualité Document signé	VALIDATION : 3/12/24 Dr A. ECKMAN Médecin Signature : 	APPROBATION : 22/11/24 Pr N. MOTTE Chef de pôle Signature : 
Liste de diffusion :			
Relecture périodique du document - sans modification par : le :			

5 - Critères de gravité :

- PAS > 180 mm d'Hg et/ou 120 mm d'Hg
- Douleur épigastrique et/ou hypocondre droit en barre persistante
- Céphalées sévères ne répondant pas au traitement antalgique
- Troubles visuels ou auditifs persistants
- Déficit neurologique
- Trouble de la conscience
- Réflexes ostéo tendineux vifs, polycinétiques et diffus
- Crise d'éclampsie
- Détrese respiratoire
- Œdème aigu du poumon
- HELLP Syndrome
- Insuffisance rénale aiguë (Doublement de la créatinine ou > 96 µmol/L)

6 - Mise en place d'un traitement anti hypertenseur :

L'objectif tensionnel est PAS <135 et PAS<85

En cas de prééclampsie non sévère ou de prééclampsie sévère sans signe de gravité :

- Traitement anti hypertenseur par voie per os
- LABETALOL per os en première intention
- Si échec : LABETALOL + NICARDIPINE ou LABETALOL + ALPHA METHYLDOPA

Posologie per os :

- LABETALOL (Trandate 200mg) : jusqu'à 8 cp par jour
- NICARDIPINE (Loxen 50mg LP) : 1 cp matin et soir avec interdose possible Loxen 20mg
- ALPHA METHYLDOPA (Aldomet 250 mg) : jusqu'à 500 mg trois fois par jour

En cas de prééclampsie sévère avec signe de gravité :

Hospitalisation

- Examen clinique complet
- Pose de VVP
- Bilan HTA et pré opératoire
- Mesure de la tension automatisée au brassard
- Monitoring foetal, en fonction du terme
- Traitement anti hypertenseur par voie intraveineuse
- Surveillance régulière de la tension avec pour objectif PAS < 160 mm d'Hg et PAD < 110 mm d'Hg

Choix du traitement anti hypertenseur LABETALOL en première intention

- Si échec : LABETALOL + NICARDIPINE ou LABETALOL + URAPIDIL

<u>Agent anti-hypertenseur IV</u>	<u>Modalités et précautions d'utilisation</u>	<u>Stratégie de titration par bolus IV</u>	<u>Perfusion continue IVSE</u>
Labétalol (Trandate)	En première intention <i>Contre- indications : Asthme, BPCO, Bradycardie, Trouble de la conduction cardiaque</i>	1^{er} bolus : 20 mg IV sur > 2 min ↓ Si échec 2^{ème} bolus : 40 mg IV sur > 2 min ↓ Si échec 3^{ème} bolus : 80 mg IV sur > 2min ↓ Si échec 4^{ème} bolus : 80 mg IV sur > 2 min ↓ Si échec Poursuite Labétalol 1 mg/kg/h IVSE et ajout d'un 2^{ème} anti hypertenseur	0.5 à 1 mg/kg/h <i>Objectif : PAS < 160 et Pad < 110 mm d'Hg</i>
Nicardipine (Loxen)	En seconde intention	Bolus 0.5 mg en IV sur > 2 min à répéter 3 fois si échec ↓ Si échec Poursuite Nicardipine 4 mg/h IVSE et ajout d'un 2^{ème} anti hypertenseur	0.5 à 4 mg/h <i>Objectif : PAS < 160 et Pad < 110 mm d'Hg</i>
Urapidil (Eupressyl)	En seconde intention ou en association	Bolus 6.25 à 12.5 mg en IV sur > 2 min à répéter 3 fois si échec ↓ Si échec Poursuite Urapidil 50 mg/h IVSE et ajout d'un autre anti hypertenseur	10 à 60 mg/h <i>Objectif : PAS < 160 et Pad < 110 mm d'Hg</i>

Echec : Persistance d'une PAS > 180 et/ou PAD > 120 mm d'Hg à 10 minutes

Dès l'obtention du PAS < 180 et PAD < 120 mm d'Hg contrôlée pendant 10 minutes, poursuite du traitement IVSE continu à la dose minimale efficace pour obtenir une PAS < 160 et PAD < 110 mm d'Hg.

Une fois la TA contrôlée par traitement IV, relai per os :

- LABETALOL en première intention
- Si échec : LABETALOL + NICARDIPINE ou LABETALOL + ALPHA METHYLDOPA

7 - Indication mise en place de Sulfate de Magnésium :

Mise en place en cas de prééclampsie sévère avec signe de gravité.

Posologie : Bolus 4 g IVL (sur 30 min) puis 1 g/h IVSE A poursuivre 24 heures

Contre-indications : insuffisance rénale, maladies neuromusculaires.

Effets secondaires : Nausées, vomissements, sensation ébrieuse, confusion, vertige, bouffées de chaleur

Surveillance :

L'instauration d'un traitement par sulfate de magnésium requiert une surveillance en salle de naissances ou soins intensifs par un personnel soignant familier de cette pathologie.

Surveillance répétée :

- Niveau de conscience (Score de Glasgow = 15)
- Contrôle pluriquotidien des ROT
- Fréquence respiratoire, SpO2
- Diurèse
- Monitoring multiparamétrique de base (électrocardiographie, pression artérielle et SpO2.)

Les signes d'hypermagnésémie (abolition des ROT) imposent l'arrêt immédiat de la perfusion de sulfate de magnésium jusqu'à la réapparition des ROT

Manifestations du surdosage :

- Abolition des ROT ET/OU
- Diminution de la force musculaire ET/OU
- Fréquence respiratoire < 16 cycles /mn ET/OU
- SpO2 < 92% ET/OU
- Nausées ET/OU
- Diplopie, troubles de l'élocution, somnolence.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Dépression respiratoire ou arrêt respiratoire et arrêt cardiaque imposent :

- L'arrêt immédiat de la perfusion de sulfate de magnésium
- Décubitus latéral gauche
- Dosage du taux de magnésémie si suspicion clinique de surdosage
- Perfusion de 1 g de gluconate de calcium sur 15 mn
- Accélération de l'élimination du magnésium par les diurétiques de l'anse si inefficace
- Surveillance continue obstétricale et anesthésique en SSPI ou réanimation selon disponibilité du plateau technique
- Si diurèse < 25ml/H :
 - o Diminuer la posologie du sulfate de magnésium à 0.5g/H et Surveillance rapprochée des ROT et fréquence respiratoire tous les 1/4 heures

1 ampoule de gluconate de calcium dans seringue et 1 canule de Guedel doivent systématiquement être prêtes dans la pièce

Durée du traitement : 72H maximum et 24 H minimum après la dernière crise d'éclampsie



8 - Prise en charge de la prééclampsie en hospitalisation :

- Réalisation d'une protéinurie sur 24h de référence
- Pas de surveillance systématique de la protéinurie par la suite
- Surveillance clinique : Tension artérielle, diurèse, signes fonctionnels d'HTA, poids, apparition d'œdèmes
- Bilan sanguin à renouveler si :
 - o Apparition de signes cliniques de sévérité ou de gravité
 - o Absence de contrôle tensionnel
- Réalisation d'une échographie obstétricale référée
- Maturation pulmonaire à discuter en fonction de la sévérité
- ERCF 2/jour, à discuter selon la gravité clinique, échographique et biologique

9 - Critères d'arrêt de grossesse :

Prééclampsie sévère :

- *Entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de poursuivre la grossesse jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée*
- *Après 34 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de prendre en charge l'accouchement*

Prééclampsie non sévère :

- *Entre 34 et 37 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de poursuivre la grossesse avec une surveillance rapprochée*
- *Entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée, il est recommandé de prendre en charge l'accouchement*

10 - Prise en charge en post partum :

- Anatomopathologie du placenta
- Visite post natale au CHU avec bilan HTA à 6 semaines de l'accouchement, protéinurie des 24h et rapport P/C